

Sen jest *lekarstwem*

75% dorosłych z ADHD ma problem ze snem. Niedospanie nasila wszystkie objawy. Sen to nie luksus — to leczenie.

CZAS: 10 min czytania **WDROŻENIE:** 2-4 tygodnie

ŹRÓDŁO: Hvolby (2015); Coogan i McGowan (2017); Van Veen i wsp. (2010); Walker (2017)

JAK UŻYWAĆ

Trzy kotwice: **stała pora wstawania** (również w weekendy — to najważniejsze), **brak ekranów** na 1 godzinę przed snem, **rytuał zamknięcia dnia** (zapisz wszystko, co chodzi po głowie). Jeśli zasypianie zajmuje > 60 min — porozmawiaj z psychiatrą o melatoninie 0,5-3 mg.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Problemy ze snem występują u **50-75%** dorosłych z ADHD (Hvolby 2015) i są jednocześnie *objawem* i *nasilaczem* ADHD. Mechanizm: mózg ADHD produkuje melatoninę średnio **1,5 godziny później** niż neurotypowy (Van Veen i wsp., 2010) — to nie „sowa z wyboru”, to opóźniona faza snu (ang. *delayed sleep phase disorder*). Coogan i McGowan (2017): dysregulacja rytmu dobowego sięga poziomu molekularnego (geny zegarowe CLOCK, PER). Skutek: niedobór snu < 6 godzin zwiększa reaktywność emocjonalną o **60%** (Walker 2017), obniża uwagę i pamięć roboczą. Leczenie snu to często *pierwszy krok* skutecznej terapii ADHD — bez niego stymulanty działają słabiej.

01 Trzy specyficzne wzorce snu w ADHD

1 · OPÓŹNIONA FAZA SNU

„sowa biologiczna”

Naturalne zasypianie 1-4 w nocy. Niezdolność do zaśnięcia przed 24:00 mimo zmęczenia. Trudność z budzeniem rano. Nie nawyk — **biologia**.

2 · GONITWA MYŚLI

„mózg się włącza w łóżku”

W ciągu dnia rozproszony/-a, wieczorem — nagle wszystkie pomysły, lęki, wspomnienia. Cisza w łóżku to **moment, gdy mózg zaczyna pracować**.

3 · NIESPOKOJNY SEN

rzucanie się, parasomnie

Częste wybudzenia. Rzucanie się. *Zespół niespokojnych nóg* 2x częstszy w ADHD. Budzisz się tak samo zmęczony/-a, jak szedłeś/szłaś spać.

02 Osiem zasad higieny snu ADHD

1 · Stała pora wstawania. Również w weekendy. *Najważniejsza reguła.* Kotwicz rytm dobowy mocniej niż pora kładzenia.

2 · Bez ekranów godzinę przed. Niebieskie światło hamuje melatoninę — która i tak jest opóźniona w ADHD. Książka, ciepłe światło, rozmowa.

3 · Brain dump. Zapisz wszystkie myśli, zadania, lęki na kartce. Mózg uznaje za „domknięte” — przestaje krążyć.

4 · Sypialnia zimna i ciemna. 18-19°C. Rolety zaciemniające. Białe szumy maskujące hałas. *Sypialnia tylko do snu* — nie pracy, nie scrollu.

5 · Kofeina stop o 14:00. Okres półtrwania 5-7 godzin — kawa o 16:00 nadal działa o 22:00. ADHD często ma osłabiony metabolizm kofeiny.

6 · Ruch w ciągu dnia. 30 min aerobiku — ale nie 2 godziny przed snem. Wzmacnia presję snu wieczorem.

7 · Światło dzienne rano. 15-30 min naturalnego światła w ciągu godziny od wstania. Przesuwa rytm dobowy „do przodu” — leczy opóźnioną fazę snu. Najsilniej działa zimą i jesienią.

8 · Melatonina (z lekarzem). Dla osób z opóźnioną fazą snu: 0,5-3 mg, 1-2 godziny *przed* planowanym zaśnięciem (Van Veen 2010). To **nie środek nasenny** — to regulator rytmu. Niska dawka skuteczniejsza niż wysoka.

03 Twój dziennik snu — 2 tygodnie

Bez danych nie ma pracy nad snem. Wypełniaj *codziennie rano*. Po 2 tygodniach pokaż lekarzowi/-rce lub terapeutce/-cie — to dane diagnostyczne.

DZ.	PORA W ŁÓŻKU	PORA ZAŚNIĘCIA <i>szacunek</i>	POBUDKI <i>liczba</i>	PORA WSTANIA	JAKOŚĆ SNU <i>1–10</i>	ENERGIA DZIEŃ <i>1–10</i>
<i>Pn</i>						
<i>Wt</i>						
<i>Śr</i>						
<i>Cz</i>						
<i>Pt</i>						
<i>Sb</i>						
<i>Nd</i>						

04 Kiedy iść do lekarza

CHRAPANIE + ZMĘCZENIE

Bezdech senny współwystępuje z ADHD u **20–30%**.
Badanie polisomnograficzne. Bezdech leczony często poprawia objawy ADHD same w sobie.

NIESPOKOJNE NOGI

„Mrowienie” w nogach wieczorem, ulga przy ruchu.
Zespół niespokojnych nóg — wymaga oceny ferrytyny i konsultacji.

HIGIENA SNU NIE POMAGA

Po 4 tygodniach stosowania zasad bez poprawy →
terapia poznawczo-behawioralna bezsenności
(CBT-I) — złoty standard, lepszy niż leki nasenne.

SENNOŚĆ DZIENNA

Zasypianie w trakcie spotkań, jazdy, czytania mimo
„przespanej” nocy. Skala Epworth > 10 → konsultacja,
możliwa narkolepsja lub bezdech.

Klucz: Sen w ADHD nie jest „kwestią dyscypliny”. To **biologia rytmu dobowego**, która u *większości* pacjentów wymaga celowanego leczenia. Hvolby (2015): poprawa snu u dorosłych z ADHD redukuje objawy nieuwagi $d = 0,5$ i regulacji emocji $d = 0,6$ — często skuteczniej niż dodatkowa farmakoterapia. Jeśli musisz wybrać *jedną* rzecz do zmiany w stylu życia, zacznij od snu. Wszystko inne staje się łatwiejsze.